Test small

Niveau : DES
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Test small

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Épidémiologie et Introduction

L'épidémiologie, discipline fondamentale en santé publique, constitue une pierre angulaire de la compréhension et de la gestion des pathologies dermatologiques. Elle se définit comme l'étude de la distribution et des déterminants des états ou événements liés à la santé dans des populations spécifiques, et l'application de cette étude au contrôle des problèmes de santé (Alikhan et Hocker, 2012). En dermatologie, l'épidémiologie permet d'appréhender la charge des maladies cutanées, d'identifier les facteurs de risque, d'évaluer l'efficacité des interventions thérapeutiques et préventives, et d'orienter les politiques de santé publique. Une maîtrise des principes épidémiologiques est donc indispensable pour tout dermatologue de niveau DES, afin d'interpréter la littérature scientifique, de concevoir des études pertinentes et d'optimiser la prise en charge des patients.

I. Principes Épidémi

Présentation Clinique

Le cours suivant est rédigé à l'attention des internes en Dermatologie préparant le Diplôme d'Études Spécialisées (DES), avec un niveau d'expertise hospitalo-universitaire.**

Présentation Clinique

L'examen clinique constitue la pierre angulaire du diagnostic en dermatologie. Une observation méthodique et la reconnaissance de signes dermatologiques spécifiques sont essentielles pour orienter le raisonnement diagnostique et thérapeutique. Au-delà de la simple description des lésions élémentaires, l'identification de signes cliniques particuliers, souvent éponymes ou descriptifs, permet d'évoquer des pathologies spécifiques, qu'elles soient purement cutanées ou l'expression de maladies systémiques. Cette section détaillera les principaux signes sémiologiques et les présentations

Diagnostic

Diagnostic

Le diagnostic en dermatologie repose sur une démarche clinique rigoureuse, complétée par des examens paracliniques ciblés, permettant d'établir une certitude diagnostique et d'orienter la prise en charge thérapeutique. Cette section détaillera les approches diagnostiques générales et spécifiques à diverses dermatoses d'intérêt pour le DES.

I. Principes Généraux du Diagnostic en Dermatologie

Le processus diagnostique débute invariablement par une anamnèse approfondie et un examen clinique exhaustif, suivis, si nécessaire, d'explorations complémentaires.

A. Interrogatoire

L'interrogatoire constitue la première étape fondamentale, permettant de recueillir des informations cruciales sur l'histoire de la maladie, les antécédents personnels et familiaux, les traitements en cours, et l'exposition à des facteurs environnementaux ou professionnels (Dermatologie, 2022). Il vise à caractériser la dermatose dans le temps (début, évolution, facteurs déclenchants ou aggravants), dans l'espace (localisation initiale et extension des lésions), et dans sa symptomatologie associée (prurit, douleur, signes généraux). Par exemple, pour une dermatose prurigineuse diffuse chez un enfant, l'interrogatoire recherchera un asthme familial ou un herpès labial récidivant chez la mère, éléments pouvant orienter vers une dermatite atopique ou une surinfection (Dermatologie, 2022).

B. Examen Clinique

L'examen clinique dermatologique doit être méthodique et complet, incluant l'inspection de l'ensemble du tégument, des phanères et des muqueuses. Il permet d'identifier les lésions élémentaires, leur morphologie, leur topographie, leur couleur, leur consistance et leur disposition. Des signes cliniques spécifiques peuvent être recherchés. Par exemple, le signe d'Asboe-Hansen, caractérisé par l'extension d'une bulle à la peau adjacente non bulleuse sous pression mécanique, est positif dans le pemphigus et d'autres maladies bulleuses comme la pemphigoïde bulleuse (BP), la dermatite herpétiforme (DH), l'épidermolyse bulleuse acquise (EBA), la pemphigoïde cicatricielle (CP), l'épidermolyse bulleuse dystrophique (DEB), les éruptions bulleuses médicamenteuses, et les syndromes de Stevens-Johnson/nécrolyse épidermique toxique (SJS/TEN) (Mann, 2017). Le signe d'Auspitz, qui se manifeste par une surface rouge et brillante avec des saignements punctiformes après le grattage ou le raclage d'une squame, est typique du psoriasis en plaques, mais peut également être observé dans la maladie de Darier et les kératoses actiniques (Mann, 2017). Le signe de Darier, provoquant une urtication, un érythème

circonférentiel et un prurit localisé après le grattage ou le frottement d'une lésion, est associé aux affections avec une augmentation des mastocytes dans le derme, telles que l'urticaire pigmentosa, la mastocytose systémique, les réactions aux piqûres d'insectes, le neurofibrome, le xanthogranulome juvénile et la leucémie lymphoblastique néonatale aiguë (Mann, 2017). Pour la rosacée, le diagnostic positif repose sur la reconnaissance des éléments cliniques caractéristiques de ses formes vasculaire, papulo-pustuleuse et hypertrophique (Dermatologie, 2022). De même, pour la dermatite séborrhéique, les éléments cliniques positifs sont déterminés par l'âge, la topographie des lésions et le terrain du patient (Dermatologie, 2022).

C. Examens Complémentaires

Les examens complémentaires sont choisis en fonction de l'orientation clinique et peuvent inclure des analyses biologiques, des examens histopathologiques, des techniques d'immunofluorescence, et des tests génétiques.

II. Diagnostic des Tumeurs Cutanées Mélaniques

Le diagnostic des tumeurs mélaniques, en particulier le mélanome, est un processus complexe nécessitant une évaluation clinique minutieuse et une confirmation histopathologique.

A. Examen Histologique

L'examen histologique de la pièce d'exérèse est l'étape clé pour le diagnostic de certitude du mélanome (Dermatologie, 2022). Il permet de :

- **Affirmer la nature mélanocytaire** : L'utilisation de marquages immunohistochimiques spécifiques tels que Melan-A, la protéine S100 et HMB45 est essentielle pour confirmer l'origine mélanocytaire de la lésion (Dermatologie, 2022).
- **Affirmer la malignité et déterminer le sous-type anatomoclinique** : L'analyse histologique permet de distinguer les lésions bénignes des mélanomes et de classer ces derniers selon leur profil histologique (Dermatologie, 2022).
- **Recueillir les paramètres histopronostiques fondamentaux** : Ces paramètres incluent l'indice de Breslow (épaisseur tumorale), la présence d'ulcération et l'index mitotique, qui sont cruciaux pour l'évaluation du pronostic et la stadification de la maladie (Dermatologie, 2022).
- **Préciser le caractère complet ou non de l'exérèse** : L'examen des marges chirurgicales détermine si l'exérèse est complète. Une reprise chirurgicale est systématiquement envisagée en cas de marges positives (Dermatologie, 2022).
- **Rechercher la présence d'une mutation de BRAF** : Selon l'avis de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), notamment pour les tumeurs épaisses de mauvais pronostic, la recherche d'une mutation de BRAF peut être effectuée d'emblée sur la pièce opératoire, afin d'orienter d'éventuelles thérapies ciblées (Dermatologie, 2022).

B. Classification Anatomoclinique

La classification anatomoclinique du mélanome regroupe les différents profils en cinq grandes catégories, dont le pronostic est globalement comparable à indice de Breslow identique (Dermatologie, 2022).

• **Mélanomes avec phase d'extension horizontale initiale** :

* **Mélanome superficiel extensif (Superficial Spreading Melanoma ou SSM)** : C'est le type le plus fréquent (60 à 70 % des cas). Il présente une croissance intra-épidermique horizontale avant une phase de croissance verticale dermique (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome de type Dubreuilh** : Représentant environ 10 % des cas, il siège sur les zones chroniquement photo-exposées, principalement le visage des sujets de plus de 60 ans, souvent associé à des signes de photovieillissement. Son évolution est horizontale pendant des mois ou des années avant de devenir invasif, notamment sous forme de nodules à croissance verticale (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome acral lentigineux (Acral Lentiginous Melanoma ou ALM)** : Constituant 2 à 5 % des cas, il est majoritaire chez les sujets à peau pigmentée. Il se localise sur les paumes, les plantes, les bords latéraux des doigts et des orteils, ainsi que sur l'appareil unguéal (Dermatologie, 2022).

* **Mélanomes des muqueuses buccales et génitales** (Dermatologie, 2022).

• **Mélanome sans phase d'extension horizontale initiale** :

* **Mélanome nodulaire d'emblée** : Il représente 10 à 20 % des cas et se caractérise par une évolution rapidement verticale invasive, parfois achromique (Dermatologie, 2022).

C. Diagnostic Différentiel et Exérèse Diagnostique

Le diagnostic différentiel du mélanome est crucial pour éviter les erreurs diagnostiques. Il inclut des lésions bénignes et d'autres tumeurs cutanées (Dermatologie, 2022).

• **Lésions bénignes** :

* **Lentigos de petite taille** : Petites macules pigmentées de quelques millimètres, à contours géographiques, de teinte uniforme et fixe, siégeant sur les zones photo-exposées ou de coups de soleil (Dermatologie, 2022).

* **Éphélides** (« taches de rousseur ») : Semis de petites macules brun clair dont la pigmentation s'accentue avec le soleil, développées uniquement sur les zones exposées (Dermatologie, 2022).

* **Histiocytofibrome** : Lésion dure à la palpation avec invagination centrale et couronne pigmentée (Dermatologie, 2022).

* **Kératose séborrhéique** : Lésion pigmentée la plus fréquente après 40 ans, à surface rugueuse, d'aspect « gras » ou « cérébriforme », bords rectilignes, correspondant à une prolifération épidermique (Dermatologie, 2022).

* **Angiome** : Tumeur vasculaire bénigne, surtout si thrombosé (Dermatologie, 2022).

• **Autres tumeurs** :

* **Carcinome basocellulaire (CBC) nodulaire** : Surtout s'il est pigmenté, il est plus ferme, recouvert de fines télangiectasies, à croissance lente et prédominant sur les zones exposées (Dermatologie, 2022).

Le diagnostic différentiel est plus difficile avec un lentigo de grande taille ou un mélanome débutant de type superficiel extensif, voire un mélanome nodulaire, pour lesquels les critères morphologiques classiques (règles « ABCD ») peuvent ne pas s'appliquer (Dermatologie, 2022). L'examen en épiluminescence (dermatoscopie) est un outil précieux pour distinguer ces diverses lésions d'un nævus ou d'un mélanome (Dermatologie, 2022). En cas de doute diagnostique, l'exérèse chirurgicale de la lésion est impérative pour un examen anatomopathologique, seule méthode permettant un diagnostic de certitude (Dermatologie, 2022). Il est important de noter que l'exérèse d'un nævus ne provoque pas sa transformation maligne (Dermatologie, 2022).

III. Diagnostic des Dermatoses Bulleuses Auto-

Traitement

Traitement des Affections Dermatologiques

La prise en charge thérapeutique en dermatologie est complexe et doit être individualisée, tenant compte de la pathologie sous-jacente, de sa sévérité, de son retentissement sur la qualité de vie du patient, des localisations cutanées, de l'existence d'atteintes associées (par exemple, articulaires), des contre-indications potentielles et des antécédents médicaux du patient (Dermatologie, 2022). Une approche collaborative entre le médecin traitant et le dermatologue est essentielle, s'inscrivant dans une stratégie au long cours pour les maladies chroniques. L'information et l'éducation thérapeutique du patient sont primordiales pour favoriser l'adhésion au traitement et la gestion quotidienne

Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi en dermatologie constituent des piliers fondamentaux de la prise en charge des patients, englobant la détection précoce des récidives tumorales, l'identification des nouvelles lésions cutanées, la gestion des effets indésirables liés aux traitements systémiques et l'évaluation de l'efficacité thérapeutique. Cette démarche rigoureuse s'inscrit dans une perspective de médecine basée sur les preuves, où la qualité des recommandations est directement corrélée au niveau de preuve scientifique disponible (Garbe et al., 2025).

Principes Généraux de la Surveillance

La mise en place d'un programme de surveillance et de suivi repose sur une évaluation approfondie des bénéfices attendus et des risques potentiels, tant pour la maladie elle-même que pour les interventions thérapeutiques.

Évaluation des Bénéfices et des Risques

L'évaluation des bénéfices d'un test de dépistage ou d'une stratégie de surveillance repose sur des preuves issues de revues systématiques d'essais randomisés, considérées comme le plus haut niveau de preuve. Un essai randomisé individuel ou, exceptionnellement, une étude observationnelle avec un effet dramatique, peut également soutenir la valeur d'un test de détection précoce (Garbe et al., 2025). Pour les effets indésirables des traitements, la hiérarchie des preuves est similaire. Les effets indésirables rares sont idéalement étudiés par des revues systématiques d'essais randomisés ou des essais n-of-1. Les effets indésirables à long terme nécessitent une durée de suivi suffisante pour être correctement caractérisés. Les études de cohorte non randomisées, bien que de niveau de preuve inférieur, peuvent être utiles pour la pharmacovigilance post-commercialisation, à condition qu'elles incluent un nombre suffisant de patients pour exclure un effet indésirable courant (Garbe et al., 2025).

Les recommandations cliniques sont graduées selon leur niveau de force :

- **Grade A (recommandation forte) :** L'action "doit" (shall) être entreprise.
- **Grade B (recommandation) :** L'action "devrait" (should) être entreprise.
- **Grade C (recommandation en attente) :** L'action "peut/peut être" (may/can) être envisagée (Garbe et al., 2025).

Le niveau de preuve peut être déclassé en fonction de la qualité de l'étude, de l'imprécision, de l'indirectness (quand le PICO de l'étude ne correspond pas au PICO de la question), de l'incohérence entre les études, ou si la taille de l'effet absolu est très faible. Inversement, il peut être reclassé à la hausse en cas de taille d'effet importante ou très

importante. Il est à noter qu'une revue systématique est généralement supérieure à une étude individuelle (Garbe et al., 2025).

Méthodologie de la Surveillance des Effets Indésirables

La surveillance des effets indésirables (EI) est une composante essentielle du suivi thérapeutique. Elle doit être exhaustive et prolongée. Par exemple, dans le cadre d'études cliniques, le suivi des EI se poursuit pendant au moins 70 jours après la dernière dose du traitement à l'étude, ou jusqu'à la résolution ou la stabilisation de tout événement en cours (Hodi et al., 2010). La gravité des EI est généralement évaluée selon des critères standardisés, tels que les *National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events* (NCI CTCAE), version 4.0 (Robert et al., 2015) ou version 4.03 (Dummer et al., 2020), et rapportée en utilisant des dictionnaires médicaux réglementaires comme le *Medical Dictionary for Regulatory Activities* (MedDRA) version 19.0 (Dummer et al., 2020).

Des règles d'arrêt de traitement sont souvent définies dans les protocoles d'étude pour garantir la sécurité des patients. Par exemple, si 10 % ou plus des patients d'un groupe de traitement développent un EI toxique de grade 3 ou plus, non dermat

Bibliographie

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Majzner et al. - 2022 - GD2-CAR T cell therapy for H3K27M-mutated diffuse midline gliomas

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Hauschild et al. - 2012 - Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma a multicentre, open-label, phase 3 randomised contro

• nmsc

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• squamous

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• Casey et al. - 2017 - FDA Approval Summary Sonidegib for Locally Advanced Basal Cell Carcinoma

• Hodi et al. - 2010 - Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

• Kaufman et al. - 2016 - Avelumab in patients with chemotherapy-refractory metastatic Merkel cell carcinoma a multicentre, s

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma

• Robert et al. - 2015 - Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation

• Tai et al. - 2025 - Immune Checkpoint Inhibitors in Merkel Cell Carcinoma of the Skin A 2025 Comprehensive Review

• Dummer et al. - 2020 - Long-term efficacy and safety of sonidegib in patients with advanced basal cell carcinoma 42-month

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin